

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ISRA · INVENTARIO DE SITUACIONES Y RESPUESTAS DE ANSIEDAD

Evaluación interactiva y multidimensional de la ansiedad en los tres sistemas de respuesta (Lang) y cuatro áreas situacionales (Endler)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (ISRA)
Autores Originales	Juan José Miguel-Tobal y Antonio Cano-Vindel (1986, 1988, 1994, 2002)
Editorial Titular	Hogrefe TEA Ediciones (Madrid, España). Desarrollado íntegramente en español.
Tipo de Instrumento	Autoinforme psicométrico multidimensional e interactivo (formato S-R)
Población Diana	Adolescentes y adultos (a partir de 16 años) en ámbitos clínico, forense y de selección
Tiempo de Aplicación	Forma completa: 30 a 50 minutos; Forma abreviada ISRA-B: 15 minutos
Formato de Respuesta	Matriz interactiva Situación x Respuesta con escala de frecuencia 0 (Casi nunca) a 4 (Casi siempre)
Finalidad Clínica	Perfilado tridimensional de la ansiedad (cognitiva, fisiológica y motora) y determinación de la reactividad ante cuatro tipos de estresores contextuales para guiar la psicoterapia conductual

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

El ISRA es considerado uno de los desarrollos psicométricos más sofisticados y sólidos de la psicología hispanohablante, estructurado sobre dos pilares conceptuales contemporáneos: el **modelo interactivo de la personalidad** de Norman Endler y el **modelo del triple sistema de respuesta a la ansiedad** de Peter Lang. Dicho marco postula que la ansiedad no es una respuesta homogénea y sincrónica, sino que se manifiesta de forma fraccionada e individual en tres canales bioconductuales que pueden mostrar desincronía (discordancia entre lo que el paciente siente, piensa y hace).

El instrumento cruza sistemáticamente los 3 sistemas de respuesta (Cognitivo: rumiación, miedo; Fisiológico: taquicardia, sudoración; Motor: tartamudeo, escape) con 4 áreas situacionales específicas de inducción de estrés: F1 Ansiedad de evaluación o rendimiento social, F2 Ansiedad interpersonal o en relaciones cercanas, F3 Ansiedad fóbica ante situaciones de daño físico o elementos específicos, y F4 Ansiedad en situaciones cotidianas o de la vida diaria.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Canal / Sistema	Nº Reactivos	Naturaleza de las Respuestas Evaluadas
Canal Cognitivo (C)	7 respuestas	Pensamientos negativos, preocupación anticipatoria, inseguridad, temor a perder el control y dificultades de memoria.
Canal Fisiológico (F)	10 respuestas	Palpitaciones, opresión torácica, sequedad de boca, sudoración, dificultades respiratorias, tensión muscular y molestias gástricas.
Canal Motor (M)	7 respuestas	Tartamudeo, movimientos repetitivos, inquietud motora, evitación de situaciones, consumo de tabaco/alcohol y llanto.
Puntuación Total Rasgo	224 interacciones	Suma C + F + M en las 22 situaciones (Índice General de Rasgo de Ansiedad).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · ISRA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach extraordinariamente alto en muestras españolas: Canal Cognitivo = 0.96; Fisiológico = 0.93; Motor = 0.90; Rasgo Total = 0.98 (Miguel-Tobal & Cano-Vindel, 2002).
Fiabilidad Test-Retest	Coefficientes de estabilidad temporal r entre 0.81 y 0.89 en intervalos de dos meses.
Validez de Constructo	Análisis factorial confirma la validez de los tres sistemas de respuesta y de los cuatro factores situacionales (FI Evaluación, FII Interpersonal, FIII Fóbica, FIV Cotidiana).
Validez Concurrente	Correlación robusta con el STAI-Rasgo ($r = 0.76$), el MAS de Taylor ($r = 0.74$) y la Escala de Ansiedad de Hamilton ($r = 0.71$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- Calificación Directa (0 a 4):** Cada intersección Situación-Respuesta se califica: 0 = Casi nunca, 1 = Pocas veces, 2 = Unas veces sí y otras no, 3 = Muchas veces, 4 = Casi siempre.
- Puntuaciones de los Tres Sistemas de Respuesta:**
 - Puntuación Cognitiva (C):** Suma de las casillas del canal cognitivo a lo largo de las situaciones.
 - Puntuación Fisiológica (F):** Suma de las casillas del canal fisiológico.
 - Puntuación Motora (M):** Suma de las casillas del canal motor.
- Puntuación Total de Ansiedad (T):** Suma $C + F + M$.
- Puntuaciones Situacionales (F1 a F4):** Suma de respuestas en situaciones de evaluación, interpersonales, fóbicas y de la vida cotidiana.
- Conversión Normativa:** Transformación obligatoria de puntuaciones directas a **Centiles (PC)** mediante los baremos oficiales de TEA Ediciones diferenciados por sexo y grupo de edad.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Rango Percentil	Nivel de Ansiedad	Significado Clínico	Orientación del Tratamiento Psicológico
Centil 0 a 25	Ansiedad Mínima / Baja	Ausente	Adecuada estabilidad emocional; reactividad adaptativa baja.
Centil 26 a 74	Ansiedad Normal / Media	Normativo	Respuestas emocionales promedio; sin significación patológica.
Centil 75 a 84	Ansiedad Moderada	Alerta	Sintomatología clínica en situaciones específicas; psicoeducación.
Centil 85 a 94	Ansiedad Severa	Clínico Claro	Trastorno de ansiedad formal; intervención psicoterapéutica focalizada.
Centil 95 a 99	Ansiedad Extrema	Invalidante	Cuadro altamente incapacitante; abordaje multidisciplinar urgente.

VALOR TERAPÉUTICO DEL PERFIL TRIDIMENSIONAL: La discordancia entre sistemas orienta directamente la técnica psicoterapéutica de elección: un paciente con predominio Cognitivo ($PC > 85$) requiere Reestructuración Cognitiva; si predomina el componente Fisiológico ($PC > 85$), la técnica de elección es el Biofeedback o la Relajación Progresiva; si predomina el Motor ($PC > 85$), Exposición en vivo y Prevención de Respuesta.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · ISRA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Aplicación y Baremación: Obtener centiles para C, F, M, Total y Factores situacionales F1-F4.

Paso 2: Prescripción Terapéutica Dirigida por Perfil:

- **Si C $\geq$ PC 85 y F/M normales:** Entrenamiento en parada de pensamiento, terapia racional emotiva o inoculación de estrés.
- **Si F $\geq$ PC 85:** Reentrenamiento respiratorio, relajación autógena o progresiva de Jacobson y biofeedback térmico/electromiográfico.
- **Si M $\geq$ PC 85:** Terapia de exposición gradual, modelado conductual y desmantelamiento de rituales o conductas de evitación.
- **Análisis Situacional:** Si se eleva selectivamente el Factor F1 (evaluación), orientar a fobia social o ansiedad ante exámenes; si es el F3, abordar como fobia específica.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 29 años, opositor a la carrera judicial, acude a consulta de psicología clínica tras bloquearse reiteradamente en los simulacros orales ante el tribunal, con temor insoportable a suspender.

Perfil Psicométrico en el ISRA (Centiles):

- **Canal Cognitivo (C):** Centil 98 (Extremo). Pensamientos continuos de incompetencia y miedo a la humillación pública.
- **Canal Fisiológico (F):** Centil 95 (Severo). Taquicardia, sudoración en las manos y sensación de nudo faríngeo que le impide vocalizar.
- **Canal Motor (M):** Centil 55 (Medio / Normativo). No presenta conductas de fuga física ni tics motores evidentes.
- **Factor Situacional I (Evaluación):** Centil 99 (Puntúa al máximo en hablar en público y someterse a exámenes).

Intervención Diseñada: El ISRA reveló un perfil clásico de Ansiedad de Evaluación con sincronía cognitivo-fisiológica y buena contención motora. Se prescribió un programa multimodal que combinó: a) reestructuración cognitiva de creencias absolutistas sobre el éxito profesional; b) biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para modular la taquicardia situacional; y c) exposición en imaginación y mediante realidad virtual a tribunales de examen. Tras 10 sesiones, los centiles Cognitivo y Fisiológico descendieron a PC 60 y PC 45, logrando el opositor aprobar el examen oral sin bloqueos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS Y DE APLICACIÓN

- Elevaciones en el centil Fisiológico (> 95) en situaciones cotidianas exigen descartar arritmias cardíacas o patología de feocromocitoma.
- La presencia de puntuaciones motoras altas vinculadas al consumo de sustancias (fumar, beber en exceso) alerta de automedicación tóxica reactiva.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Fobia Específica vs Trastorno de Pánico:** La especificidad situacional del ISRA permite delimitar si la angustia es situacionalmente predecible (F3) o inesperada.
- **Trastorno Obsesivo-Compulsivo:** Rumitaciones cognitivas del canal C que deben distinguirse de obsesiones egodistónicas.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Miguel-Tobal, J. J., & Cano-Vindel, A. (2002). *ISRA: Inventario de Situaciones y Respuestas de Ansiedad (Manual)*. TEA Ediciones.
- Miguel-Tobal, J. J., & Cano-Vindel, A. (1988). El inventario de situaciones y respuestas de ansiedad (ISRA): Fundamentación teórica y datos psicométricos. *Ansiedad y Estrés*, 1(1), 17–38.
- Lang, P. J. (1968). Fear reduction and fear behavior: Problems in treating a construct. In J. M. Shlien (Ed.), *Research in psychotherapy* (Vol. 3, pp. 90–102). American Psychological Association.
- Endler, N. S. (1980). Person-situation interaction and anxiety. In I. G. Sarason & C. D. Spielberger (Eds.), *Stress and anxiety* (Vol. 7, pp. 249–266). Hemisphere.